

INDICADO POR: Dra Priscila
X ACOMPANHAMENTO () CONSULTA
NS 2224 2217 552 | 2023

Luiz Fernando Paiva Pereira
IDADE: 35 PESO: 120 ALTURA: 1,90 PROFISSÃO: Engenheiro
SINTOMAS: Roncos presenciados, sonolência diurna

QUEIXAS:

MEDICAMENTOS: não toma

MÉDICO: Dra Priscila

MARCAPASSO: () S (X) N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S (X) N

EXERCÍCIO FÍSICO: 5x musculação

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: 5 ALMOÇO: 5 LANCHE: 5 JANTAR: 22-23h

HORA QUE DORME: 0h - 0:30h HORA QUE ACORDA: 5:30h

COCHILHO () S (X) N DORME ACOMPANHADO: (X) S () N () EVENTUALMENTE

TEM FILHOS: () S (X) N / DORMEM NO QUARTO: () S (X) N PET NO QUARTO: () S (X) N

BEBIDA ALCOÓLICA: () S () X NA SEMANA (X) N

FUMO: () S () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal

BANHEIRO/NOITE: não

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL:

CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: não

MALLAMPATI: III

IAH: 26,5cm SPO2: 78%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: não apresenta

CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (N) CARDÍACA

(N) ORTOPÉDICA

(N) NEUROLÓGICA

() OUTROS:

POLISSONOGRAMA COM CPAP: () S () N

SPO2 CI/CPAP:

PRESSÃO NO EXAME:

17/05/25 Avaliação Lacração Auto 4 a 10 cmH₂O
Mare Swift FX (M)

24/05/2025 P= 7,8 cmH₂O PRT: 10 cmH₂O
IAH= 1,12/h

muro= 5h49min

fuga= 16l/min

Deixo P. Fixa: 8,6 cmH₂O

Silva

30/05

P= 7,8 cmH₂O

IAH= 0,8 eflu

Fuga= 4h40'

Jua.

23/06

P= 8,6 cmH₂O

IAH= 0,9 eflu

m. de uso: 4h20'

fuga= 2,5 eflu.

Jua.

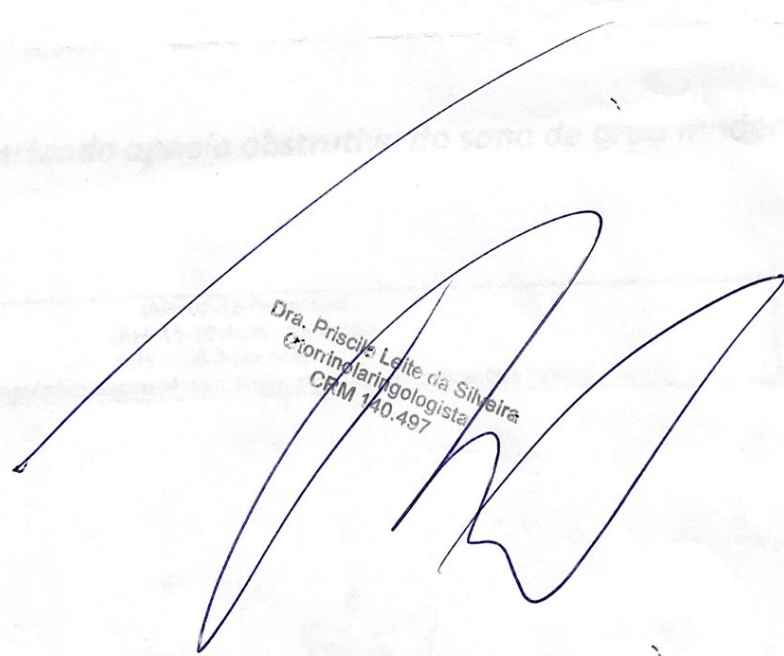
Paciente: Luiz Fernando Paiva Pereira

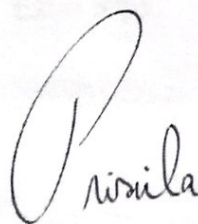
SOLICITAÇÃO DE CPAP

Paciente com roncos e apnéia Grave - IAH: 26, I/H, NADIR 78%

Solicito adaptação para CPAP, com rampa, automático, umidificador e seguimento de adaptação.

Grata,


Dra. Priscila Leite da Silveira
Otorinolaringologista
CRM 140.497


Priscila

Priscila Leite Da Silveira

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (7), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

Considerando o registro da noite inteira observou-se:

1. Índice de distúrbio respiratório moderado (26,1 n°/h) (VN= até 5 n°/h);
2. Saturação da oxi-hemoglobina preservada (78%);
3. Latência para o início do sono normal (12,5 min) (VN= 5 a 30 min);
4. Latência para o início do sono REM normal (94,0 min) (VN= 70 a 120 min);
5. Eficiência do sono preservada (87,7 %) (VN= ≥ 85%);
6. Aumento do índice de despertares (17,5 n°/h) (VN= até 15 n°/h);
7. Percentual do estágio N1 normal (3,0 %) (VN= 2% a 5%);
8. Percentual do estágio N2 normal (51,5 %) (VN= 45% a 55%);
9. Percentual do estágio N3 ondas delta normal (20,6 %) (VN= 13% a 23%);
10. Percentual do estágio REM normal (24,9 %) (VN= 20% a 25%);
11. Ronco constante verificado via sensor de ronco;
12. Presença de movimento periódico de membros inferiores com índice normal (5,4 (n°/h) (VN= até 15 n°/h);

IDR (Índice de Distúrbio Respiratório) = Índice de Apnéia + Hipopnéia + RERA

Padrão de normalidade para adultos IDR: até 5/h normal, de 5 a 15/h leve, de 15 a 30/h moderado e acima de 30/h elevado.

Padrão de normalidade para crianças até 12 anos IDR: até 1/h normal, de 1 a 5/h leve, de 5 a 10/h moderado e acima de 10/h elevado.

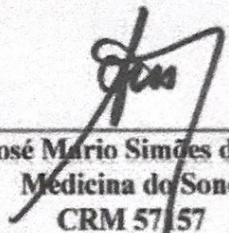
Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono de grau moderado.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157